

**Аналітична довідка
за результатами проведеного анкетування закладів охорони здоров'я на відповідність
мінімальним вимогам з інфекційного контролю
(станом на травень 2025 року)**

Вступ

За останні декілька років Міністерство охорони здоров'я України разом з ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – Центр), за всебічної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центру контролю та профілактики хвороб Сполучених Штатів Америки, Норвезького інституту громадського здоров'я та інших міжнародних партнерів докорінно змінили підходи до профілактики інфекцій та інфекційного контролю (далі – ППК), змінивши акцент із зовнішнього контролю на розвиток внутрішніх компетенцій, а саме на впровадження системи управління якістю медичних послуг. Так, раніше існуючий підхід з періодичним зовнішнім контролем з боку санітарно-епідеміологічної служби змінено на мультимодальний підхід або стратегію впровадження заходів з ППК. Саме формування безпосередньо на рівні закладу охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) команди спеціалістів і фахівців з інфекційного контролю вважається найбільш ефективним і раціональним підходом для надання якісних і безпечних медичних послуг.

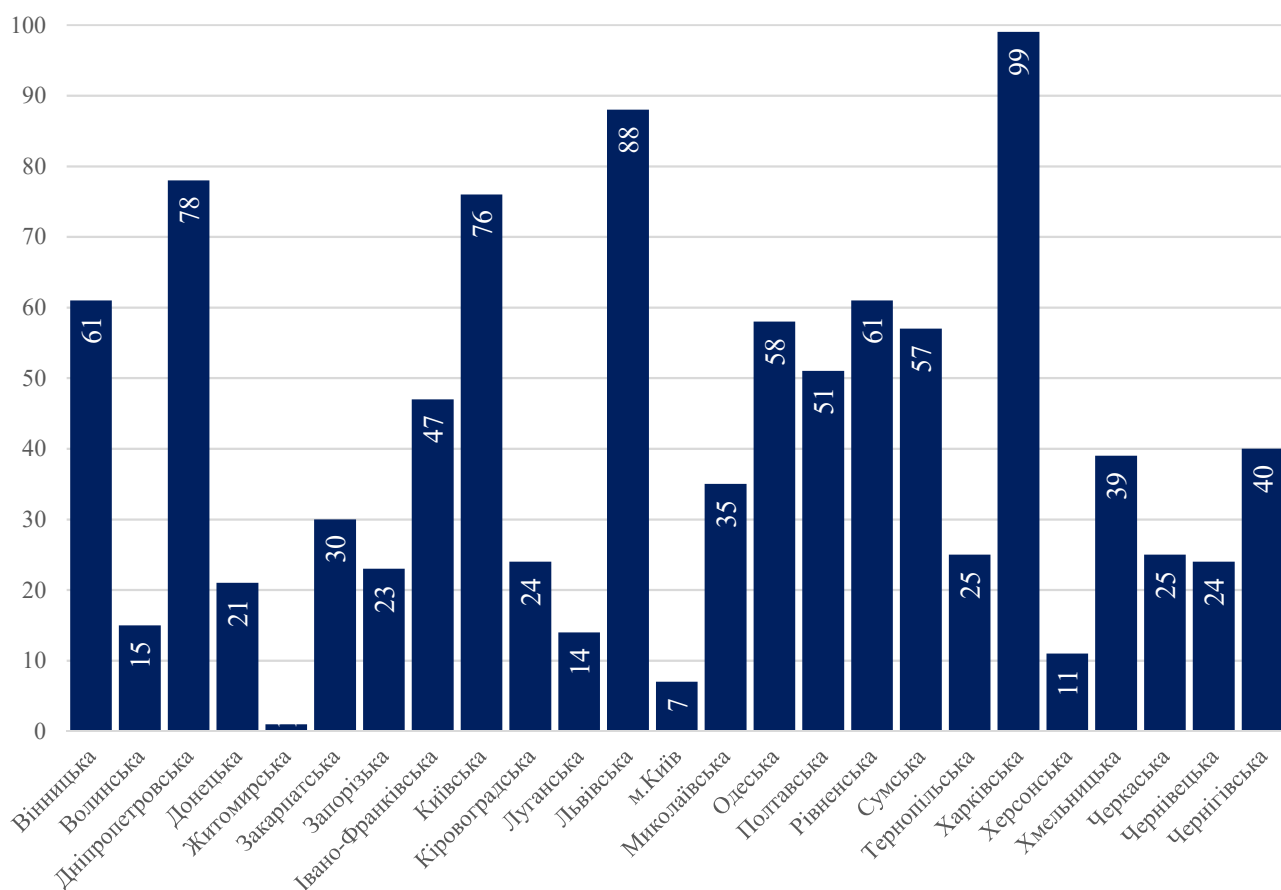
Підпунктами 1, 2 пункту 1 Переліку зобов'язань надавача щодо забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором, який наведено у додатку 3 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 376) до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, з 01 січня 2024 року передбачена обов'язкова відповідність надавача медичних послуг мінімальним вимогам з профілактики інфекцій, інфекційного контролю та протидії поширенню збудників з антимікробною резистентністю (далі – мінімальні вимоги).

З метою оцінки дотримання мінімальних вимог Центром було проведено анонімне опитування щодо дотримання мінімальних вимог надавачами медичної допомоги.

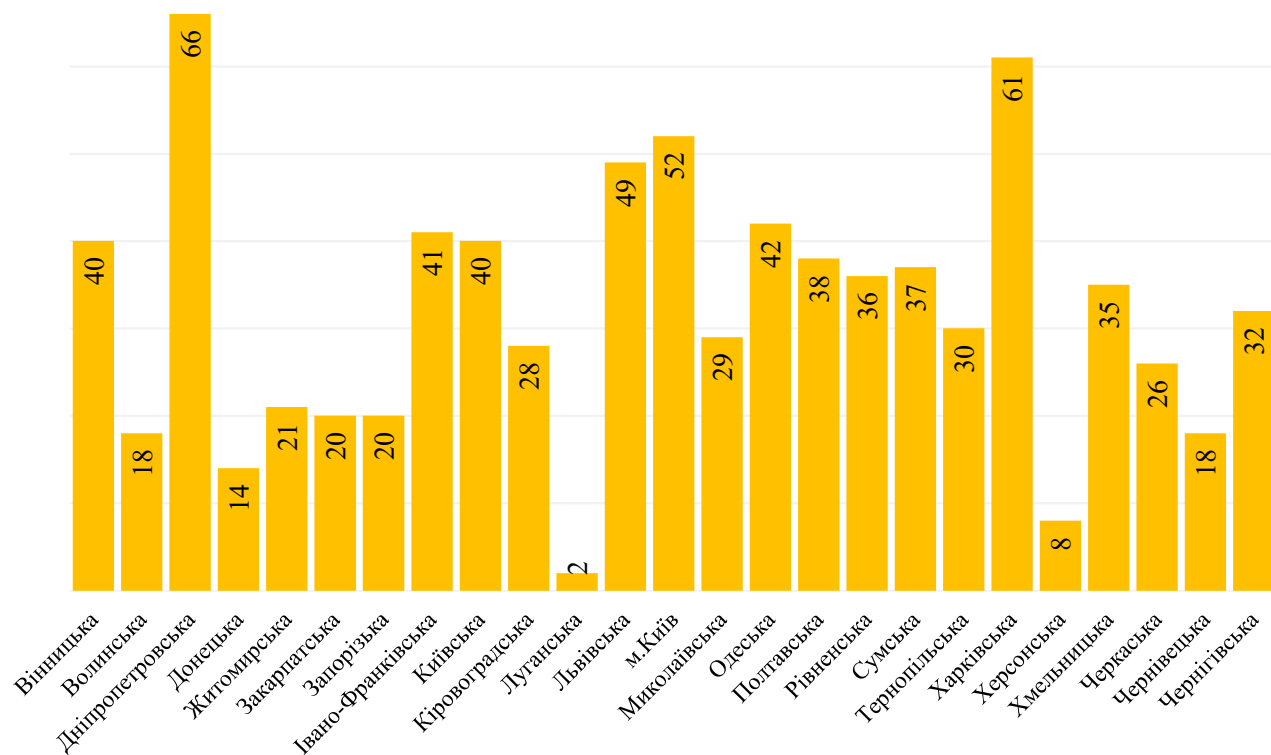
Охоплення та методологія збору даних

Дані зібрано у період з 15 квітня до 12 травня 2025 року шляхом самостійного, анонімного заповнення анкет у сервісі Google Forms закладами охорони здоров'я, що на момент розсилки мали чинні договори з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ), за амбулаторними та стаціонарними пакетами. У 2025 році обласні центри контролю та профілактики хвороб (далі – ОЦКПХ) були долучені до поширення форми серед закладів і не здійснювали подальшого адміністрування чи консолідації відповідей, що зумовило нижчий рівень охоплення порівняно з 2023 роком, проте підвищило відповідність отриманих даних фактичного стану впровадження ППК у закладах.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ, за пакетом «Амбулаторні послуги» законтраковано 1 802 заклади охорони здоров'я. В опитуванні прийняли участь 1010 закладів охорони здоров'я, що становить 56,05% від законтракованих закладів охорони здоров'я. У 2023 році участь у анкетуванні прийняло 61,4%, що на 5,35% більше ніж у поточному. За напрямом "Стаціонарні послуги загального профілю" законтраковано 1085 закладів охорони здоров'я, заповнені опитувальники отримано від 803 закладів, що становить 78% від законтракованих НСЗУ. У 2023 році участь у анкетуванні прийняло 83,3% що на 5,3% менше ніж у поточному році.



Діаграма. 1 Кількість надавачів медичної допомоги в амбулаторних умовах дорослим і дітям, які надали інформацію щодо дотримання мінімальних вимог з інфекційного контролю.



Діаграма 2 Кількість надавачів медичної допомоги в стаціонарних умовах дорослим і дітям, які надали інформацію щодо дотримання мінімальних вимог з інфекційного контролю.

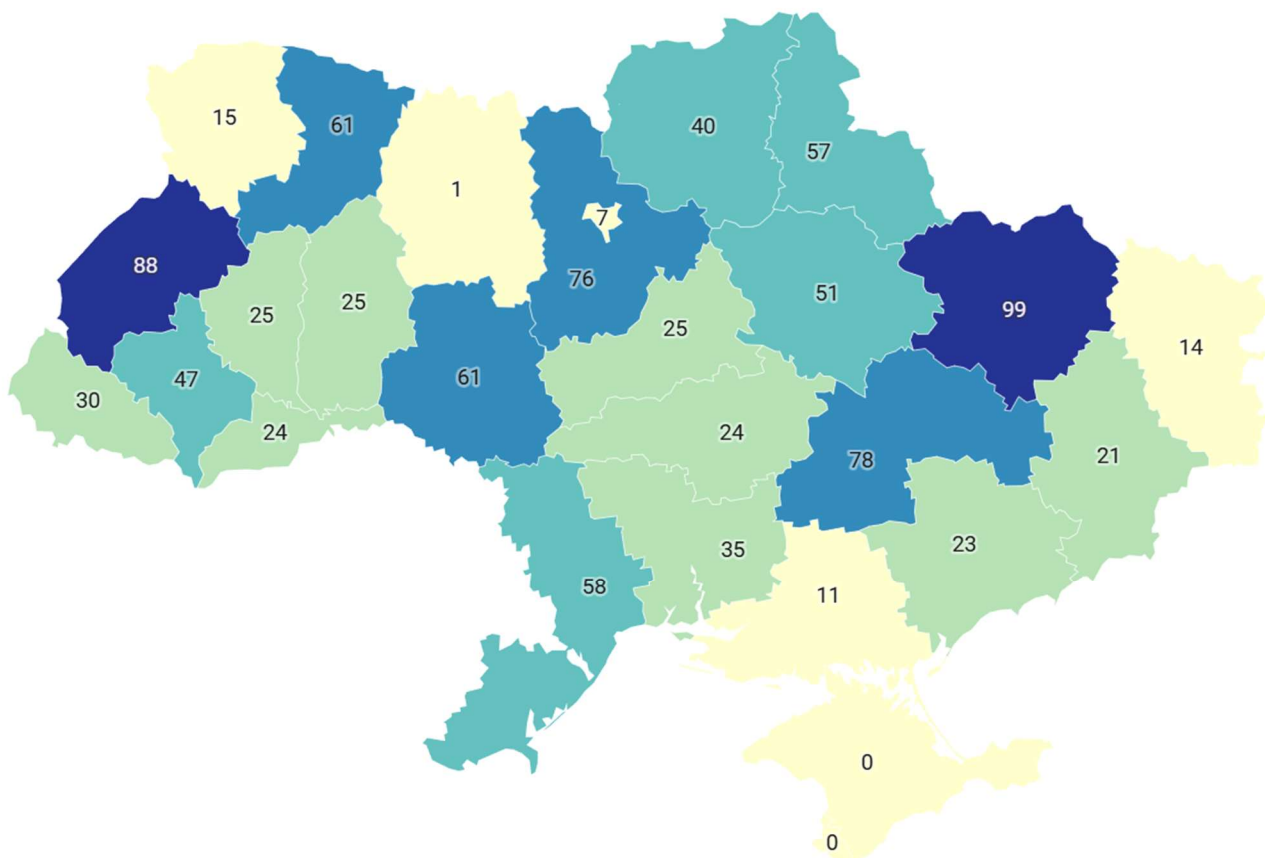


Рис. 1 Географічний розподіл надавачів медичної допомоги в амбулаторних умовах дорослим і дітям, що прийняли участь у анкетуванні.

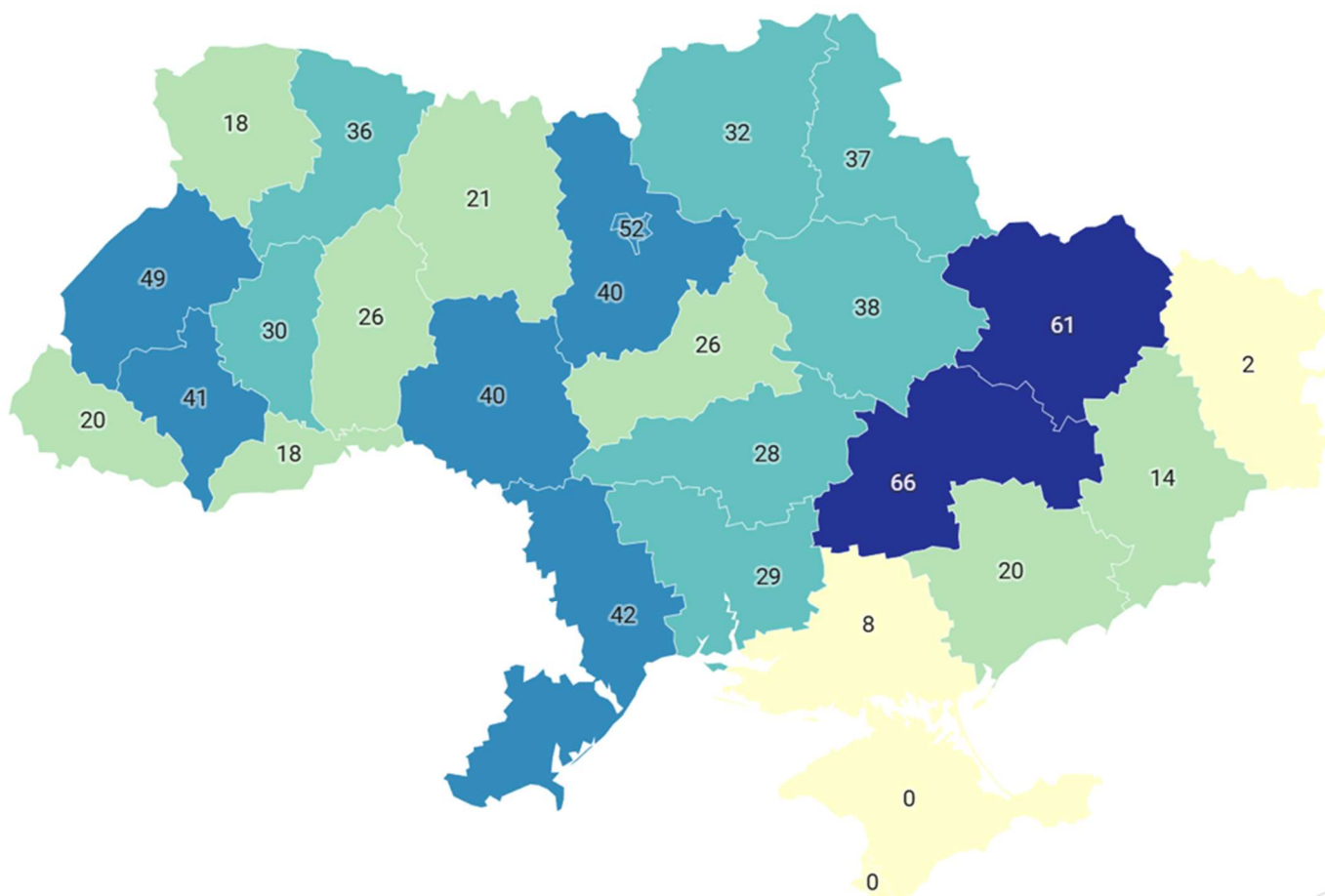


Рис. 2 Географічний розподіл надавачів медичної допомоги в стаціонарних умовах дорослим і дітям, що прийняли участь у анкетуванні.

Надавачі медичної допомоги в амбулаторних умовах дорослим і дітям

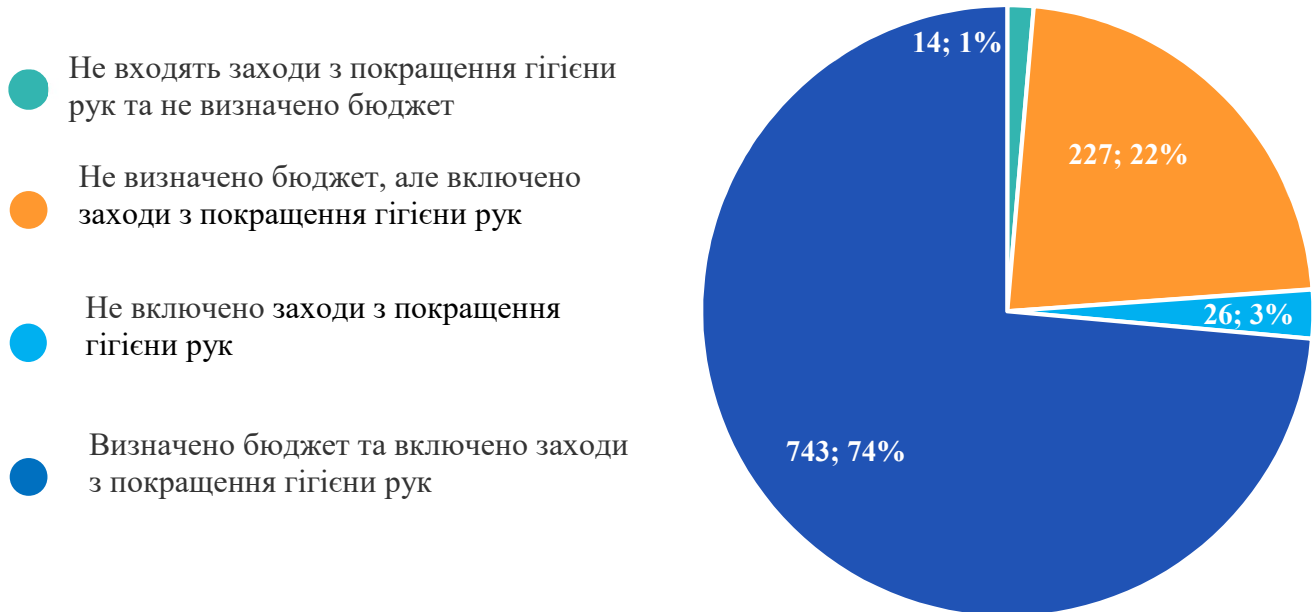
Відповідно до отриманих даних, результати дотримання мінімальних вимог з інфекційного контролю наступні:

1) кількість надавачів медичної допомоги, які мають затверджений керівником план дій з ППК на поточний рік, в тому числі визначений бюджет на його реалізацію та план дій включає заходи з покращення гігієни рук – 743 (73,56% від загальної кількості надавачів медичної допомоги);

до плану дій не входять заходи з покращення гігієни рук – 26 (2,57%);

у план дій входять заходи з покращення гігієни рук, але не визначено бюджет – 227 (22,48%);

у план дій не входять заходи з гігієни рук та не визначено бюджет – 14 (1,39%);

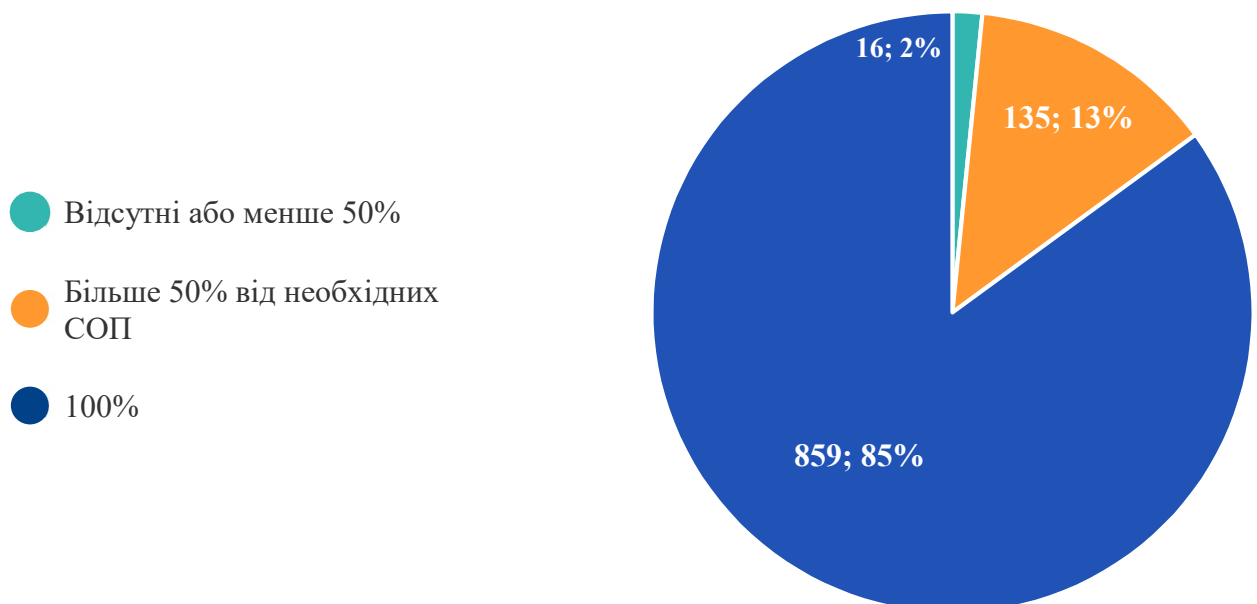


Діаграма 3 Затверджений план дій з ППК.

2) наявність у надавачів медичних послуг затверджених стандартних медичних процедур (далі – СОП) з ППК – 859 (85,5%);

наявні не всі, але більше ніж 50% від необхідних СОП – 135 (13,37%);

наявні менше ніж 50% від необхідних СОП – 16 (1,58%);

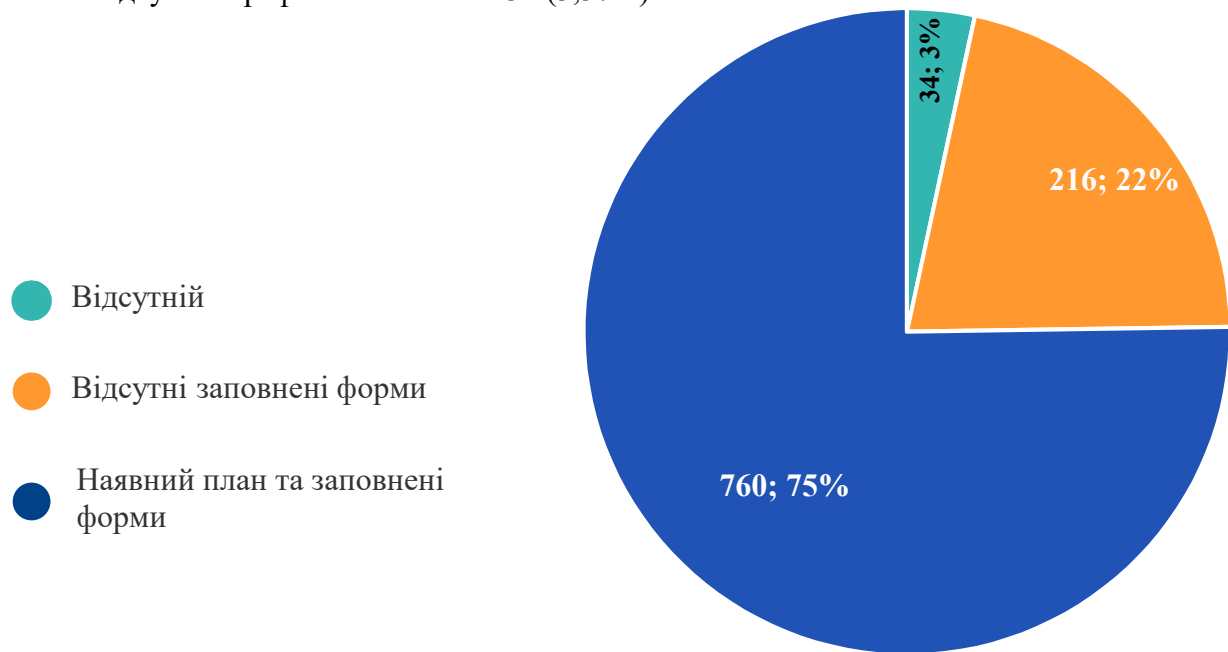


Діаграма 4 Наявність СОП.

3) наявність у надавачів медичної допомоги затвердженого графіку навчань працівників з ППК включно з підтвердними документами щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань, включно із заповненими формами – 740 (75,25%);

наявний графік з навчання, але відсутні заповнені форми проведеного анкетування знань медичних працівників – 216 (21,9%);

відсутній графік з навчання – 34 (3,37%).

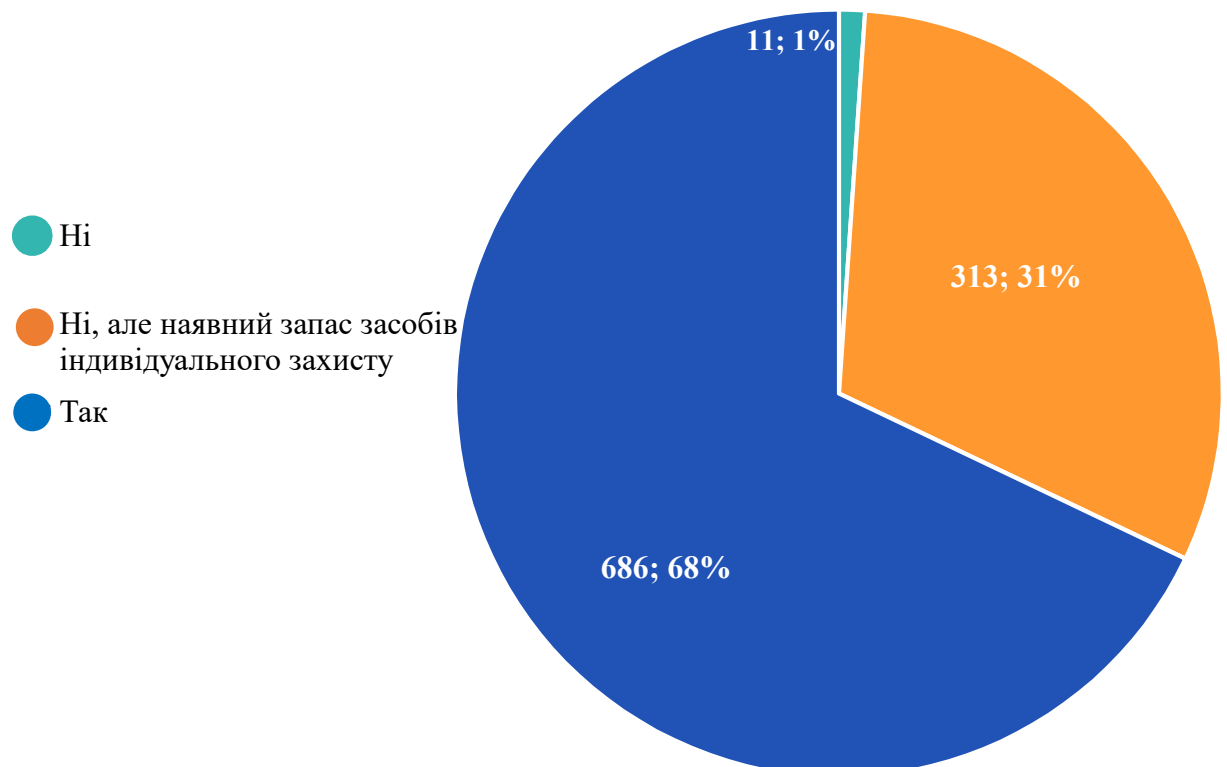


Діаграма 5 Графік навчань з ППК.

4) наявність запасу засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я – 686 (67,92%);

наявний тільки запас ЗІЗ– 313 (30,90%);

відсутній як достатній запас ЗІЗ так і засобів специфічної хіміопрофілактики – 11 (1,09%).

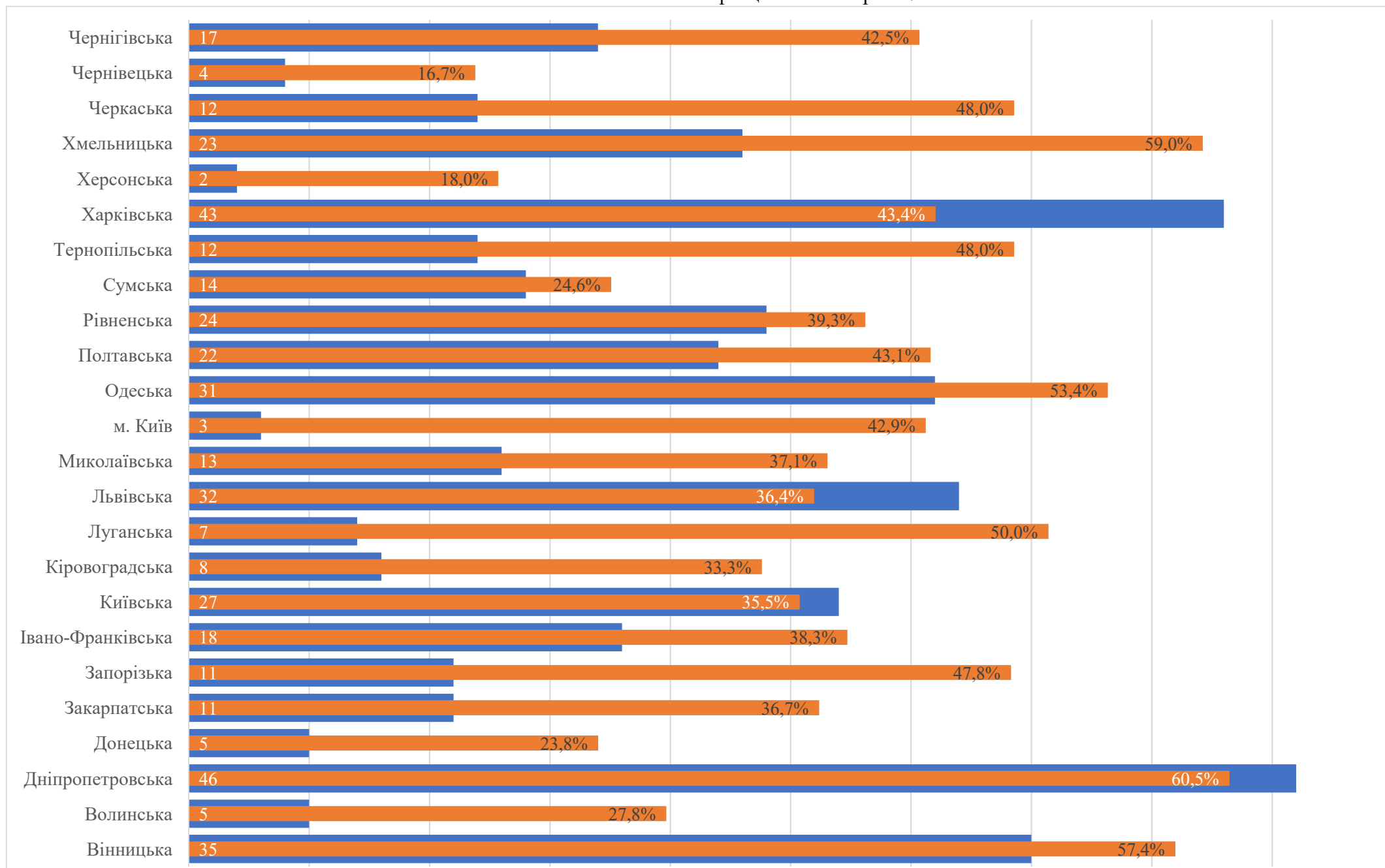


Діаграма 6 Наявність запасу ЗІЗ та хіміопрофілактики.

Таб. 1 Порівняльні результати опитування надавачів медичної допомоги в амбулаторних умовах дорослим і дітям, на відповідність мінімальним вимогам з інфекційного контролю, у розрізі 2025 та 2023 року.

Індикатор/запитання	Відповідність	2025		2023		Δ
		N	%	N	%	
Чи наявний затверджений керівником надавача медичних послуг план дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік?	Ні або НЕ визначено бюджет на його реалізацію та/або план дій НЕ включає заходи з покращення гігієни рук	14	1,39%	32	3,29%	-1,91%
	Так, але НЕ визначено бюджет на його реалізацію (за умови включення до плану дій заходів з покращення гігієни рук)	227	22,48%	274	28,19%	-5,71%
	Так, але до плану дій НЕ входять заходи з покращення гігієни рук (за умови наявності бюджету на його реалізацію)	26	2,57%	31	3,19%	-0,62%
	Так, в тому числі визначено бюджет на його реалізацію та план дій включає заходи з покращення гігієни рук	743	73,56%	635	65,33%	+8,24%
Чи наявні у надавача медичних послуг затверджені стандартні операційні процедури з профілактики інфекцій та інфекційного контролю?	Ні або наявні менше 50% від необхідних	16	1,58%	51	5,25%	-3,66%
	Ні, але наявні більше 50% від необхідних	135	13,37%	218	22,43%	-9,06%
	Так	859	85,05%	703	72,33%	+12,72%
Чи затвердженого графік навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік?	Ні або підтвердні документи відсутні	34	3,37%	54	5,56%	-2,19%
	Так, але відсутні заповнені форми проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників	216	21,39%	278	28,60%	-7,21%
	Так	760	75,25%	640	65,84%	+9,40%
Чи наявний запас засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я?	Ні	11	1,09%	16	1,65%	-0,56%
	Ні, але наявний запас засобів індивідуального захисту	313	30,99%	283	29,12%	+1,87%
	Так	686	67,92%	673	69,24%	-1,32%

Діаграма 7 Кількість надавачів медичної допомоги в амбулаторних умовах дорослим і дітям, які повністю відповідають мінімальним вимогам з інфекційного контролю та % від загальної кількості закладів, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах дорослим і дітям в регіоні, які повністю відповідають мінімальним вимогам з інфекційного контролю.



У 2025 році ЗОЗ, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах дорослим і дітям демонструють відчутний прогрес у плануванні ППК + 8,24%, наявності СОП +12,72% і навчанні +9,40%. Втім без динаміки лишається готовність до виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я, що може бути обумовлено, що може бути обумовеним гуманітарними надходженнями. В наступні роки, за відсутності підтримки благодійних організацій, тенденція із забезпеченням ЗІЗ може змінитися в гіршу сторону. Репрезентативність зменшилася на 5,35 % у порівнянні з 2023 роком, що ймовірно зумовлено зміною методики збору даних: у 2023 році анкети надсилались до ОЦКПХ, які комунікували із ЗОЗ та консолідували відповіді. У 2025 році ЗОЗ заповнювали опитувальник самостійно й анонімно. Такий перехід зменшив охоплення, через відсутність адміністративного супроводу ОЦКПХ, водночас підвищивши валідність відповідей. Комплексна відповідність* мінімальним вимогам склала **42,04%**, але враховуючи, що інформацію було надано методом самооцінювання – результати потребують валідації заявлених показників.

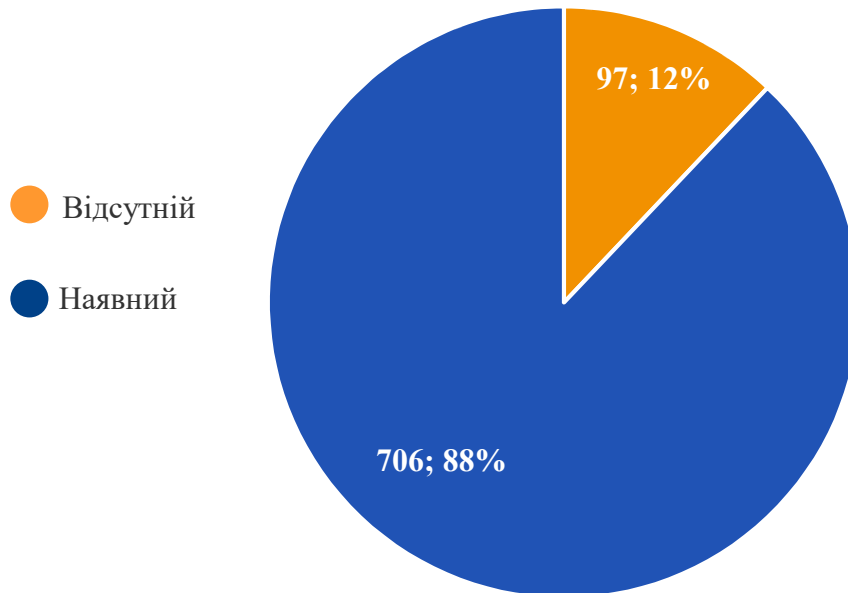
Комплексна відповідність у цьому звіті розуміється як кон'юнкція всіх наявних блоків оцінювання для кожного окремого закладу. Заклад зараховувався до таких, що мають комплексну відповідність, лише у разі позитивних відповідей за всіма обов'язковими блоками. Будь-яка відсутність або неповна відповідь у будь-якому з блоків автоматично знижувала статус закладу до «неповної відповідності».

Надавачі медичної допомоги в стаціонарних умовах дорослим і дітям

Відповідно до отриманих даних, результати дотримання мінімальних вимог з інфекційного контролю наступні:

1) кількість надавачів медичної допомоги з наявним відділом з інфекційного контролю (далі – ВІК) з розрахунку 250 ліжок на одну особу, яка працює на умовах повної зайнятості – 706 (88%);

відсутній ВІК – 97 (12%);



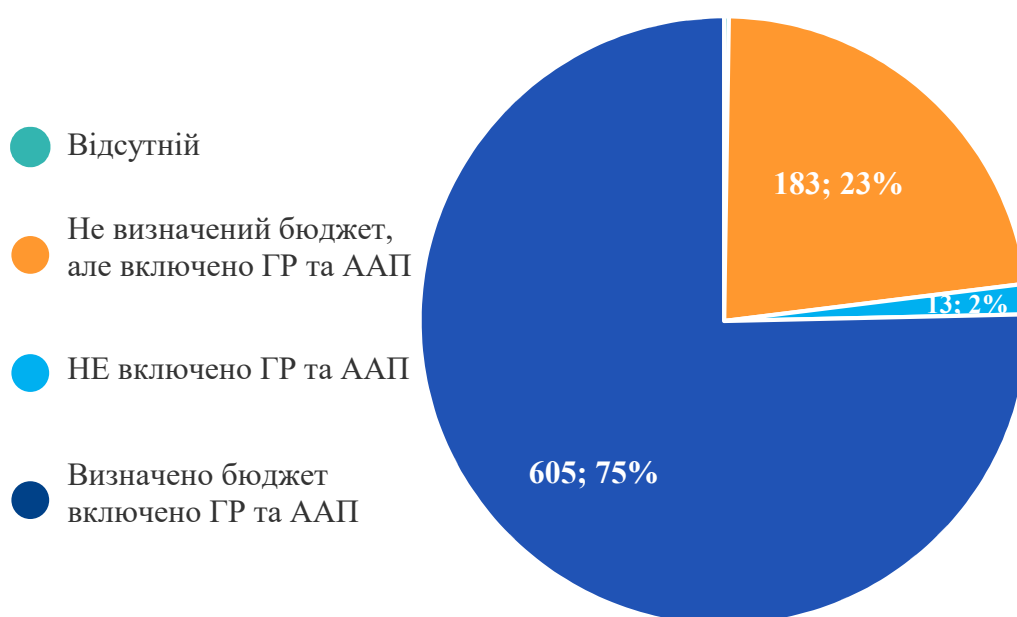
Діаграма 8 Наявність ВІК.

2) кількість надавачів медичної допомоги, які мають затверджений керівником план дій з ППК на поточний рік, в тому числі визначений бюджет на його реалізацію та план дій включає заходи з покращення гігієни рук та адміністрування антимікробних препаратів (далі – ГР та ААП) – 605 (75%);

до плану дій не входить заходи з покращення ГР та ААП – 13 (2%);

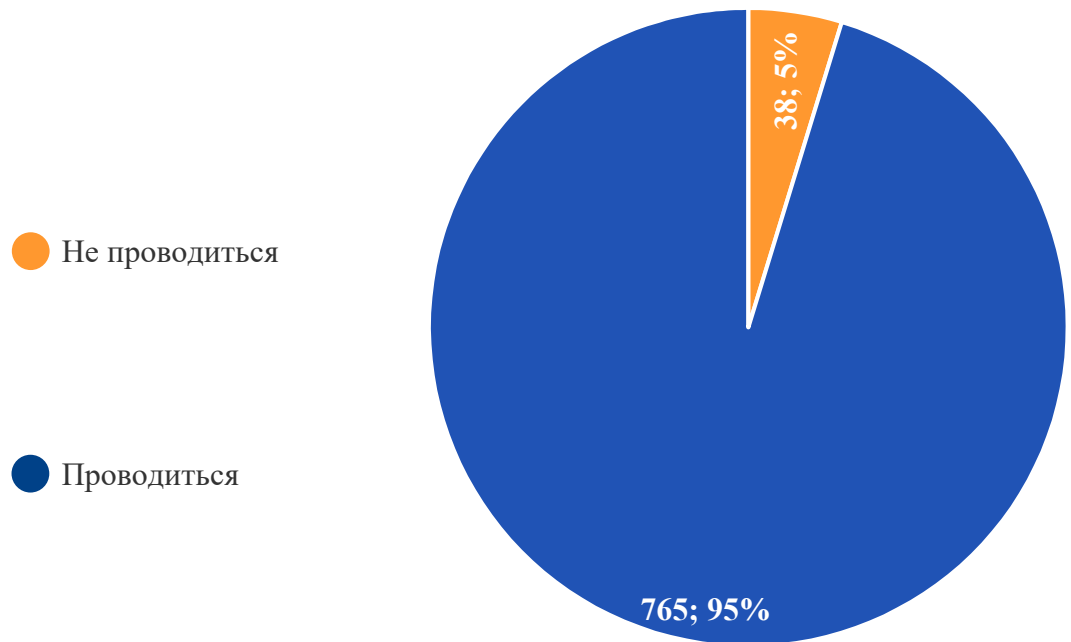
у план дій входять заходи з покращення ГР та ААП, але не визначено бюджет – 183 (23%);

план відсутній – 2 (<1%);



Діаграма 9 План дій з ППК

3) кількість надавачів медичної допомоги, де проводиться спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів – 765 (95%);
не проводиться спостереження за споживанням лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів – 38 (5%);

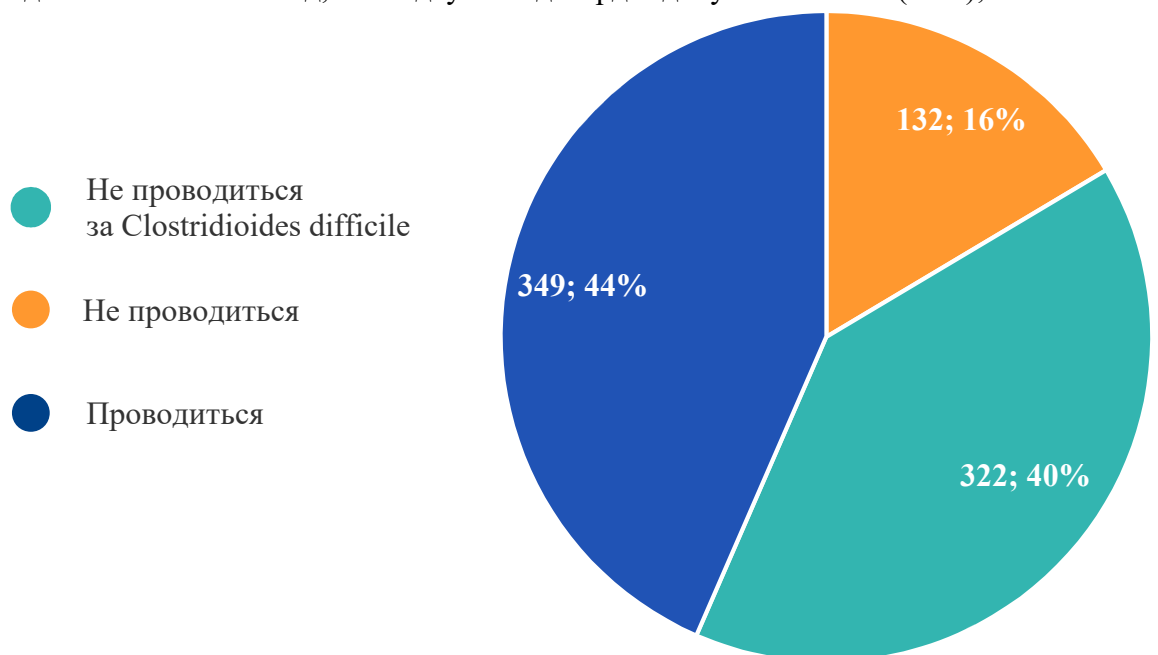


Діаграма 10 Спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів

4) кількість надавачів медичної допомоги де проводиться рутинний епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, пов'язаними з наданням медичної допомоги (далі – ППНМД), інфекціями області хірургічного втручання (за наявності хірургічних відділень), девайс-асоційованими інфекціями та інфекційними хворобами, викликаними *Clostridium difficile*, включно з проведенням моніторингу антимікробної резистентності клінічно значущих збудників та наявними підтвердними документами (звіт за результатами проведеного нагляду) – 349 (44%);

наявні підтвердні документи щодо нагляду за ППНМД, але не проводиться рутинний епіднагляд за інфекційними хворобами викликаними *Clostridioides difficile* – 322 (40%);

не проводиться епідеміологічний нагляд, або відсутні підтвердні документи – 132 (16%);

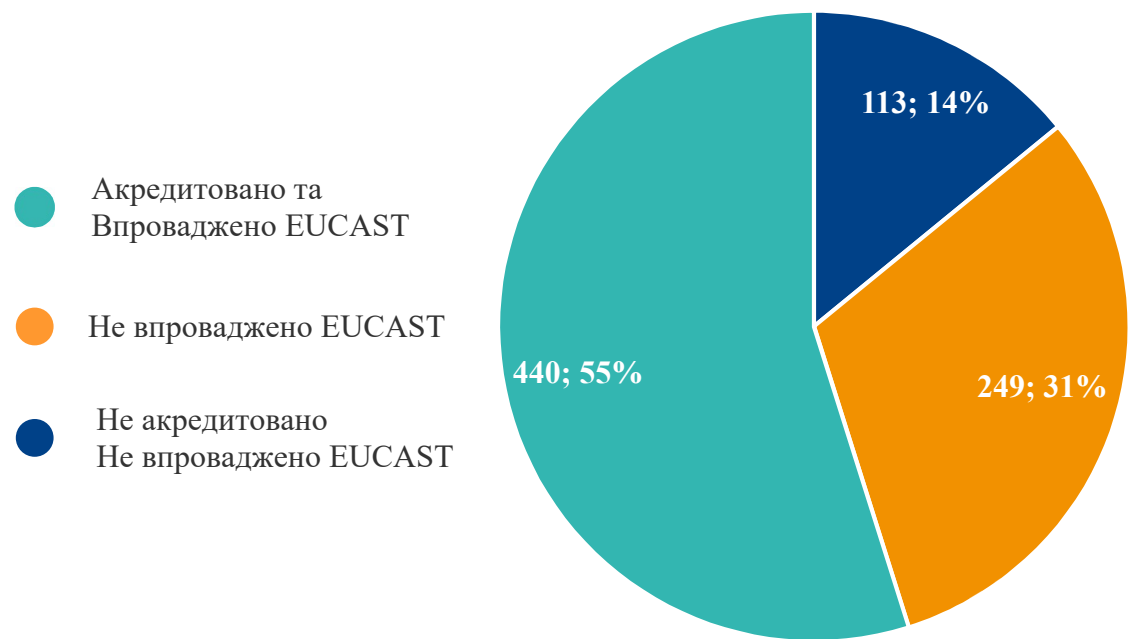


Діаграма 11 Рутинний епідеміологічний нагляд за ППНМД

5) кількість надавачів медичних послуг у структурі яких є лабораторії з впровадженою методологією визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST та лабораторія акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015 або договір з такою лабораторією – 440 (55%);

в лабораторії впроваджено методологію визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST, але лабораторія не акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015 – 249 (31%);

в лабораторії не впроваджено методологію визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST та лабораторія не акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015 – 113 (14%);



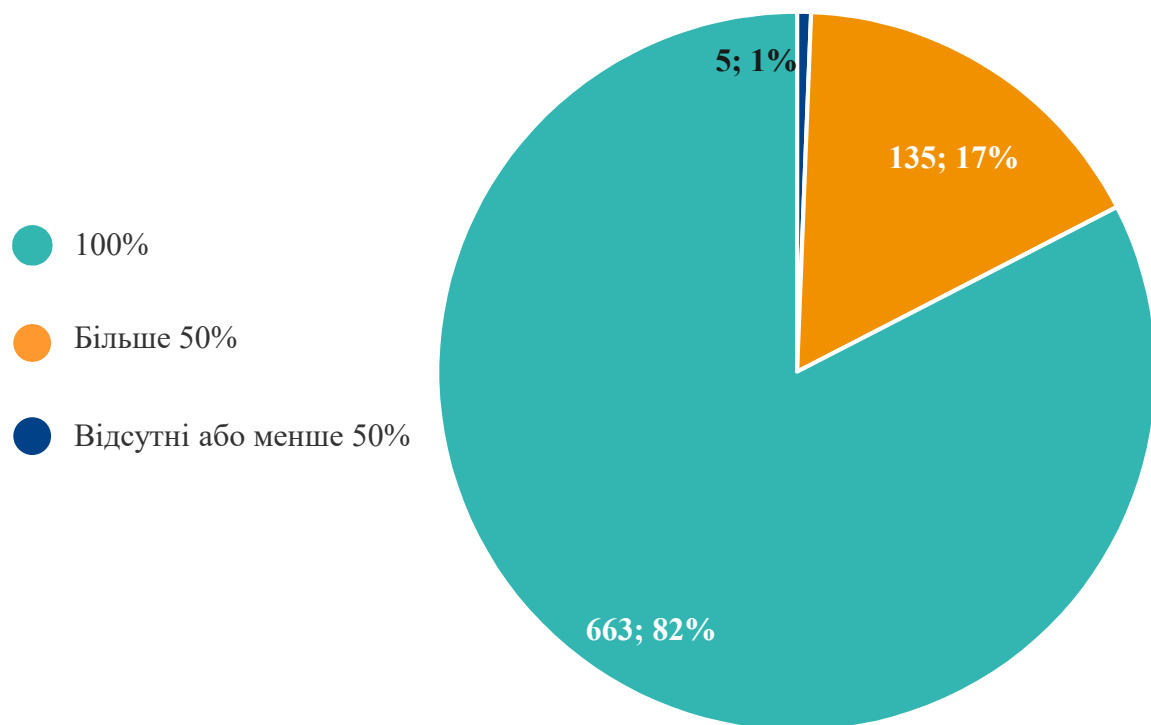
Діаграма 12 Лабораторний компонент

6) наявність у надавачів медичних послуг затверджених СОП з ПІК, а саме (гігієна рук, деконтамінація медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпека під час проведення ін'єкцій, медичне сортування (тріаж); стандартні, контактні, крапельні і аерогенні заходи із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій; перелік антимікробних лікарських засобів, які використовуються в закладі охорони здоров'я, протоколи периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії, протоколи преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів) – 663 (82%);

наявні не всі, але більше ніж 50% від необхідних СОП – 135 (17%);

наявні менше ніж 50% від необхідних СОП – 5 (1%);

Відповідно до результатів опитування, 440 надавачів послуг мають у структурному підрозділі лабораторію з впровадженою методологією визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST та лабораторія акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015 або договір з такою лабораторією. Однак, з відкритих джерел Національного агентства з акредитації України видно, що відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 15189:2015 лише 85 лабораторій, а ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 – 21 бактеріологічна лабораторія, здебільшого у ОЦКПХ та бактеріологічних лабораторій їхніх філій, районних відділів та відділень, що вимагає додаткового підтвердження наявності договорів, або відповідності вимогам у випадку наявності лабораторії у структурному підрозділі.

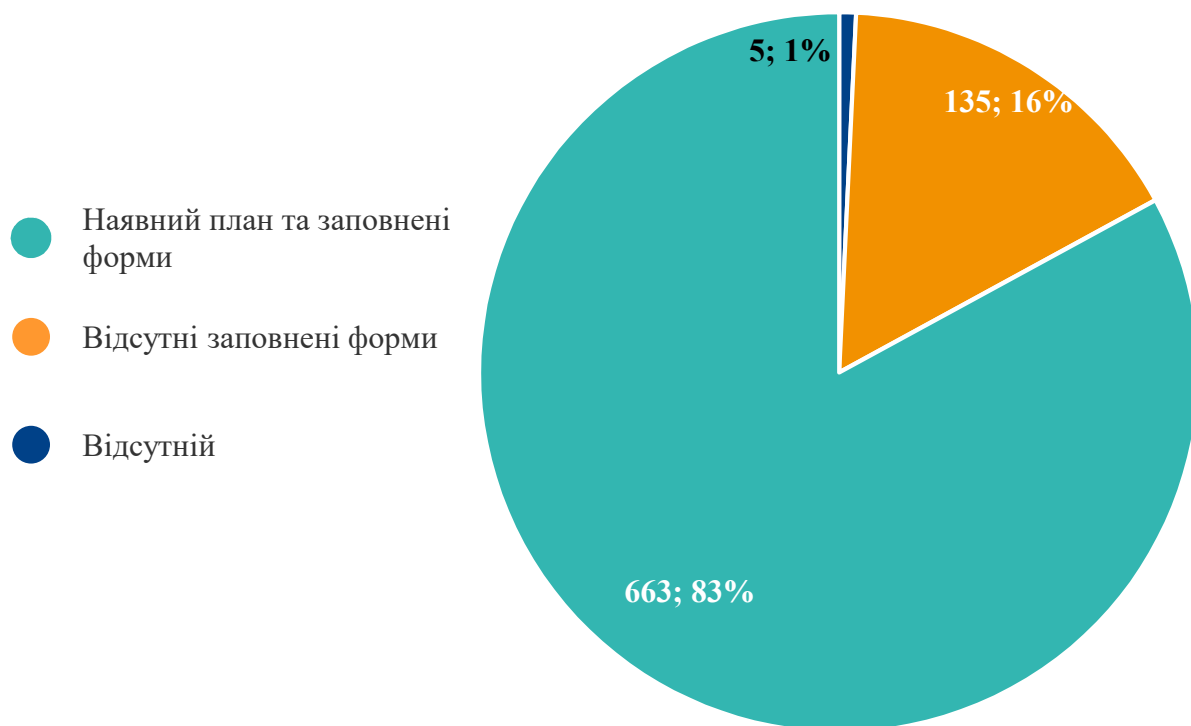


Діаграма 13 Наявність СОП

7) наявність у надавачів медичної допомоги затвердженого графіку навчань працівників з ППК включно з підтвердними документами щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань, включно із заповненими формами – 663 (83%);

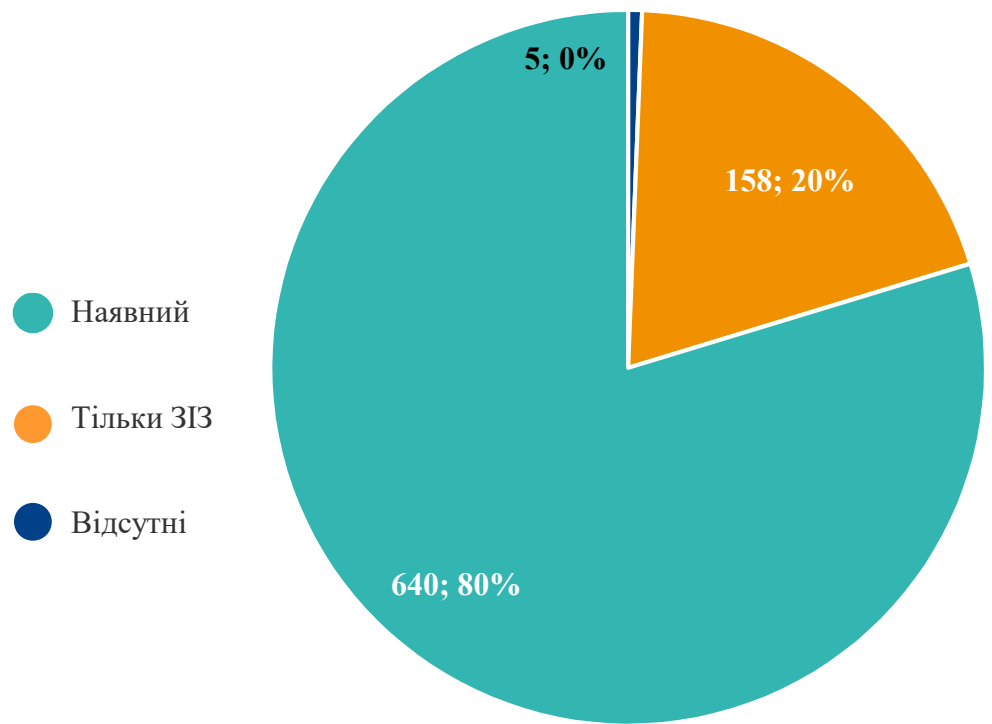
наявний графік з навчання, але відсутні заповнені форми проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників – 135 (16%);

відсутній графік з навчання – 5 (1%);



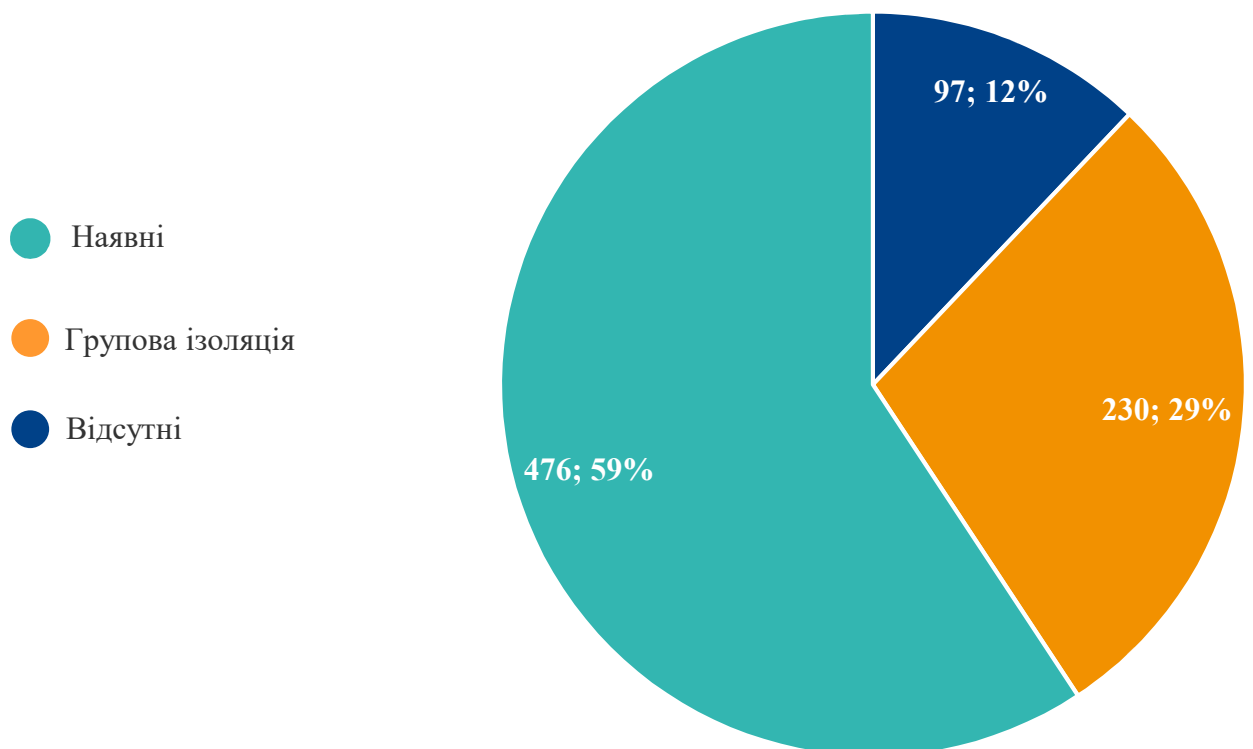
Діаграма 14 Графік навчань з ППК

8) наявність запасу ЗІЗі засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я – 640 (80%); наявний тільки запас ЗІЗ – 158 (20%); відсутній, як достатній запас ЗІЗ, так і засобів специфічної хіміопрофілактики – 5 (0%);



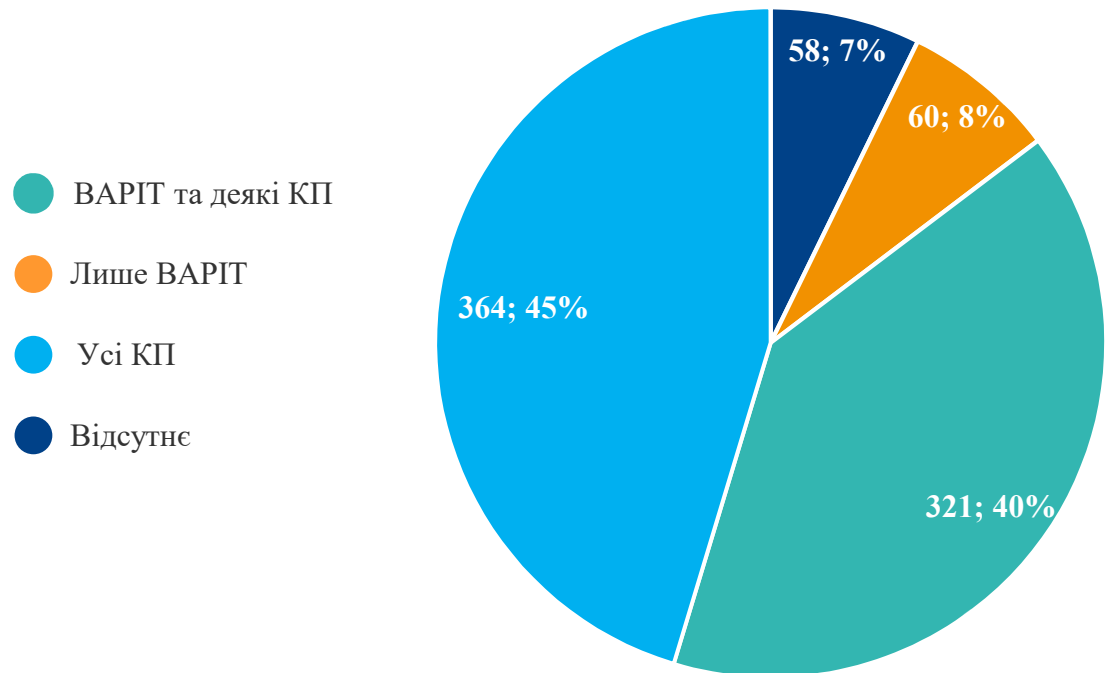
Діаграма 15 Запас ЗІЗ та засобів специфічної хіміопрофілактики

9) кількість надавачів медичних послуг де наявна одна палата на кожні 20 ліжок для індивідуальної/групової ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами з крапельним шляхом інфікування та/або пацієнтів, інфікованих мікроорганізмами з резистентністю – 476 (59%);
 наявні лише палати групової ізоляції – 230 (29%);
 відсутні палати ізоляції – 97 (12%);



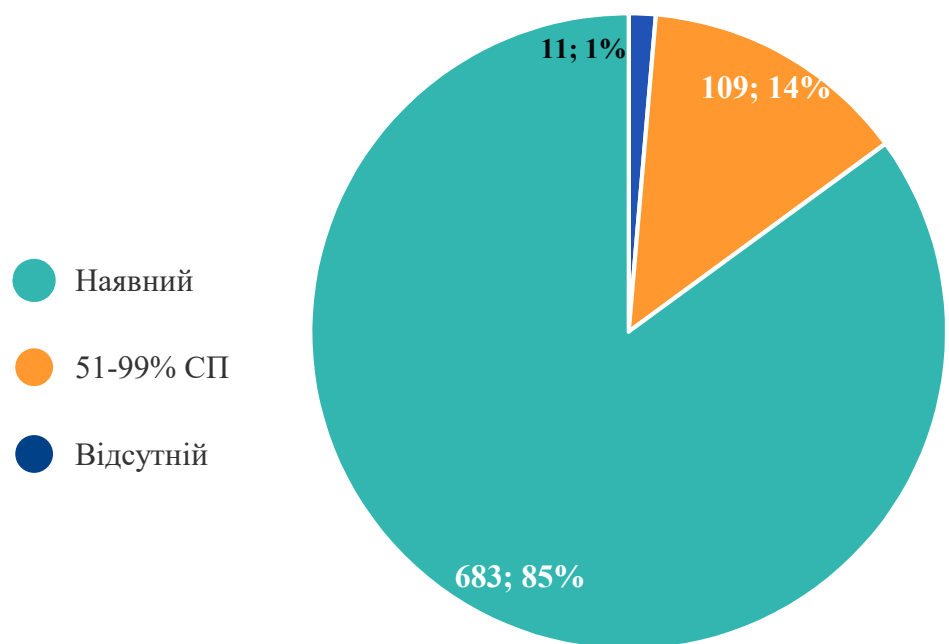
Діаграма 16 Наявність палат ізоляції

10) наявність у надавача медичних послуг відстані між ліжками (з усіх сторін), відстані в 1 метр, в усіх клінічних підрозділах - 364 (45%);
 лише у відділенні інтенсивної терапії (далі – ВАРІТ) та інших клінічних підрозділах (далі – КП) - 321 (40%);
 лише у ВАРІТ – 60 (8%);
 відсутнє дотримання відстані – 58 (7%);



Діаграма 17 Відстань між ліжками 1 метр

11) наявність мінімум одного унітазу на 20 ліжок стаціонару – 683 (85%);
 лише у 51%-99% клінічних структурних підрозділів (далі – СП) – 109 (14%);
 менш ніж у 50% - 11 (1%);



Діаграма 18 Наявність унітазу на 20 ліжок

Індикатор/запитання	Відповідність	2023		2025		Δ%
		N 3O3	% 3O3	N 3O3	% 3O3	
Чи наявний відділ з інфекційного контролю (з розрахунку 250 ліжок на одну особу, яка працює на умовах повної зайнятості)?	Ні	143	16,6%	97	12%	-4,6%
	Так	717	83,4%	706	88%	4,6%
Чи наявний затверджений керівником надавача медичних послуг план дій з ППК на поточний рік?	Ні або НЕ визначено бюджет на його реалізацію та/або план дій НЕ включає заходи з покращення ГР/ААП	208	19,8%	2	0%	-19,8%
	Так, але НЕ визначено бюджет на його реалізацію (за умови включення до плану дій заходів з покращення ГР/ААП)	327	31,1%	183	23%	-8,1%
	Так, але до плану дій НЕ входять заходи з покращення ГР/ААП (за умови наявності бюджету)	49	4,7%	13	2%	-2,7%
	Так, в тому числі визначено бюджет на його реалізацію та план дій включає заходи з покращення ГР/ААП	468	44,5%	605	75%	30,5%
Чи проводиться спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів?	Ні або відсутні підтвердні документи (лист на ЦКПХ із даними моніторингу)	184	21,4%	38	5%	16,4%
	Так, в тому числі наявні підтвердні документи (лист на ЦКПХ із даними моніторингу)	676	78,6%	765	95%	16,4%
Чи проводиться рутинний епідеміологічний нагляд ППНМД, Clostridioides difficile, включно з проведенням моніторингу антимікробної резистентності клінічно значущих збудників?	Ні або відсутні підтвердні документи (звіт за результатами проведеного нагляду)	267	31%	132	16%	15%
	Так, підтвердні документи наявні, але рутинний епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, викликаними Clostridioides difficile не проводиться	453	52,7%	322	40%	12,7%
	Так, в тому числі наявні підтвердні документи (звіт за результатами проведеного нагляду)	140	16,3%	349	44%	27,7%
Чи наявна у структурі надавача медичних послуг лабораторія мікробіологічного профілю або договір, укладений із лабораторією мікробіологічного профілю чи іншим ЗОЗ, у якого є лабораторія мікробіологічного профілю?	Ні або в лабораторії не впроваджено методологію EUCAST та не акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015	246	28,6%	113	14%	-14,6%
	Ні, в лабораторії впроваджено методологію EUCAST, але лабораторія не акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015	375	43,6%	249	31%	-12,6%
	Так, впроваджено EUCAST та акредитовано на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015	239	27,8%	440	55%	27,2%

Чи наявні у надавача медичних послуг затверджені стандартні операційні процедури з ППІК?	Ні або наявні менше 50% від необхідних	35	4,1%	5	1%	-3,1%
	Ні, але наявні 50% і більше від необхідних	301	35%	135	17%	-18%
	Так	524	60,9%	663	82%	21,1%
Чи затвердженого графік навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік?	Ні або підтвердні документи відсутні	17	2%	6	1%	-1%
	Так, але відсутні заповнені форми проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників	224	26%	131	16%	-10%
	Так	619	72%	666	83%	11%
Чи наявний запас засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопротекції на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я?	Ні	2	0,2%	5	0%	-0,2%
	Ні, але наявний запас засобів індивідуального захисту	173	20,1%	158	20%	-0,1%
	Так	685	79,7%	640	80%	0,3%
Чи наявна одна палата на кожні 20 ліжок для індивідуальної/групової ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами з крапельним шляхом інфікування та/або пацієнтів, інфікованих мікроорганізмами з резистентністю?	Ні	79	9,2%	97	12%	2,8%
	Так, але наявні лише палати групової ізоляції	227	26,4%	230	29%	2,6%
	Так	554	64,4%	476	59%	-5,4%
Чи відстань між ліжками (з усіх сторін) у палатах становить мінімум 1 метр?	Ні	60	7%	58	7%	0,00%
	Так, але лише у відділенні інтенсивної терапії	107	12,4%	60	8%	-4,4%
	Так, але лише у відділенні інтенсивної терапії та деяких інших клінічних структурних підрозділах	276	32,1%	321	40%	7,9%
	Так, в усіх клінічних структурних підрозділах	417	48,5%	364	45%	-3,5%
Чи наявний мінімум один унітаз на 20 ліжок стаціонару?	Ні	16	1,9%	11	1%	-0,9%
	Так, але лише у 51%-99% клінічних структурних підрозділів	126	14,7%	109	14%	-0,7%
	Так	718	83,5%	683	85%	1,5%

Таб. 2 Порівняльні результати опитування ЗОЗ, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах дорослим і дітям, на відповідність мінімальним вимогам з інфекційного контролю, у розрізі 2025 та 2023 року.

У 2025 році надавачі медичної допомоги в стаціонарних умовах, демонструють прогрес: у плануванні ППК +30,5%, обліку споживання АМП +16,4%, епіднагляді за ПНМД +27,7%. Без значної позитивної динаміки лишається кадровий потенціал: наявність ВІК +4,6%.

Критичним залишається відсутність нагляду за *Clostridioides difficile*: 72,3% стаціонарів не ведуть рутинний нагляд. Відмічається погіршення у розділі інфраструктури: наявність палат ізоляції -5,4% дотримання відстані 1 м між ліжками -3,5%.

Лабораторна спроможність покращилась EUCAST/акредитація +27,2%, однак частина цих показників потребує зовнішньої валідації через можливу невідповідність публічним реєстрам акредитації.

Репрезентативність знизилась на 5,3% у порівнянні з 2023 роком, що ймовірно зумовлено зміною методики збору даних.

Комплексна відповідність мінімальним вимогам у 2025 році склала **44,5%**, з огляду на самооцінювальний характер даних результати потребують додаткової документальної валідації.

Таб. 3 Порівняльні результати показників 2025-го року та динаміки від 2023 року, серед надавачів медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Індикатор/запитання	Відповідність	Амбулаторії		Стаціонари	
		Показник 2025	Δ від 2023 р.	Показник 2025	Δ від 2023 р.
Комплексна відповідність		42,04%	-	44,50%	-
Охоплення		56,05%	-5,35%	78%	-5,30%
Чи наявний затверджений керівником надавача медичних послуг план дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік?	Ні або НЕ визначено бюджет на його реалізацію та/або план дій НЕ включає заходи з покращення гігієни рук	1,39%	-1,9%	0%	-19,8%
	Так, але НЕ визначено бюджет на його реалізацію	22,48%	-5,7%	23%	-8,1%
	Так, але до плану дій НЕ входять заходи з покращення гігієни рук за умови наявності бюджету	2,57%	-0,6%	2%	-2,7%
	Так, в тому числі визначено бюджет на його реалізацію та план дій включає заходи з покращення гігієни рук	73,56%	8,2%	75%	30,5%
Чи наявні у надавача медичних послуг затверджені стандартні операційні процедури з ППК?	Ні або наявні менше 50% від необхідних	1,58%	-3,7%	1%	-3,1%
	Ні, але наявні більше 50% від необхідних	13,37%	-9,1%	17%	-18,0%
	Так	85,05%	12,7%	82%	21,1%
Чи затвердженого графік навчань медичних працівників з ППК на поточний рік?	Ні або підтвердні документи відсутні	3,37%	-2,2%	1%	-1,0%
	Так, але відсутні заповнені форми проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників	21,39%	-7,2%	16%	-10,0%
	Так	75,25%	9,4%	83%	11,0%
Чи наявний запас ЗІЗ і засобів специфічної хіміопротекції на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я?	Ні	1,09%	-0,6%	0%	-0,2%
	Ні, але наявний запас засобів індивідуального захисту	30,99%	1,9%	20%	-0,1%
	Так	67,92%	-1,3%	80%	0,3%

Охоплення вибірки зменшилось, як для амбулаторій –5,35%, так і для стаціонарів –5,3%. Це знижує репрезентативність і може спотворювати загальну картину.

Комплексна відповідність нижча за 50% для обох ланок: 42,04% - амбулаторії та 44,5% - стаціонари. Тобто менш ніж половина закладів одночасно виконують усі мінімальні вимоги

Окремі індикатори суттєво поліпшилися:

- 1) План ППК із бюджетом: частка «Відсутній/не визначено бюджет» зменшилась до 1,39% в амбулаторіях і до 0% у стаціонарах (–19,8 Δ);
- 2) Затверджені СОПи: частка закладів із показником <50% зменшилась до 1,58% в амбулаторіях (–3,66 Δ) та до 1% у стаціонарах (–3,1 Δ);
- 3) Графік навчань: частка закладів без графіка навчань або без підтверджень зменшилась до 3,37% в амбулаторіях (–2,19 Δ) та до 1% у стаціонарах (–1,0 Δ);

Запаси ЗІЗ і засобів специфічної хіміопротекції на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я лишаються без особливої динаміки, як у амбулаторних так і стаціонарних закладах.

Незважаючи на покращення окремих вимог, інтегральний показник залишається низьким, оскільки значна частка закладів не виконує всі вимоги одночасно.

Висновки

У 2025 р. охоплення анкетуванням знизилось порівняно з 2023 роком: амбулаторії на 5,35%, стаціонари на 5,3%. Перехід від моделі із залученням ОЦКПХ та зазначенням назви закладу до самостійного й анонімного заповнення, ймовірно зменшив охоплення, підвищивши валідність відповідей.

Інтегральне виконання мінімальних вимог залишається недостатнім комплексна відповідність: 42,04% в амбулаторіях і 44,5% у стаціонарах — менше половини закладів одночасно виконують усі вимоги.

Системне планування та адміністративні компоненти істотно поліпшилися на обох рівнях: Амбулаторії: план ППК із бюджетом і заходами з гігієни рук +8,24%; СОП +12,72%; графіки навчань із підтвердженням +9,40%.

Стаціонари: план ППК з бюджетом та ГР/ААП +30,5%; облік споживання АМП +16,4%; епіднагляд за ПНМД +27,7%.

Готовність до надзвичайних ситуацій на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я - без істотної динаміки.

Інфраструктура в стаціонарах відображає змішані тенденції. Погіршення індикатора палат ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами ізоляції -5,4% та дотримання 1 м між ліжками -3,5%, що вимагає цільових інвестицій або перепланувань.

Лабораторна спроможність зросла, але потребує верифікації. Частка закладів із впровадженою методологією EUCAST та акредитацією підвищилась на +27,2%. Водночас частина заявлених статусів і договорів, не відповідає даним із відкритих джерел, що потребує додаткового підтвердження.

Рекомендації

1. Національній службі здоров'я України (далі – НСЗУ) та структурним підрозділам з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій (далі – ДОЗ ОДА) провести вибірккову верифікацію достовірності отриманих даних щодо дотримання мінімальних вимог шляхом звіряння їх з державними реєстрами, чинними договорами та внутрішніми організаційно-розпорядчими документами закладів, з пріоритетом перевірки показників лабораторної спроможності та здійснення нагляду за інфекціями, пов'язаними з наданням медичної допомоги. За результатами верифікації сформувати уточнений масив даних для подальшого використання.

2. ДОЗ ОДА і центрам контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України (далі – ЦКПХ) довести до відома керівників закладів охорони здоров'я результати проведеного опитування та рекомендувати включити до планів дій з ППК заходи із безперервного забезпечення засобами індивідуального захисту із зазначенням розрахованої потреби, періодичності формування та оновлення запасів, а також із визначенням джерел фінансування.

3. ЦКПХ, у межах покладених функцій методичного супроводу, рекомендувати мікробіологічним лабораторіям закладів охорони здоров'я, незалежно від наявності акредитації, впровадити методологію EUCAST у роботу з метою уніфікації підходів до інтерпретації результатів мікробіологічних досліджень, забезпечення порівнюваності даних про антимікробну резистентність і їх подальшого використання для національного та міжнародного звітування, а також організувати моніторинг стану впровадження зазначеної методології.

4. ДОЗ ОДА та ОЦКПХ сприяти приведенню інфраструктури закладів охорони здоров'я у відповідність до мінімальних вимог з ППК та рекомендувати керівникам закладів охорони здоров'я поетапно усунути виявлені прогалини, зокрема відновити палати для ізоляції інфекційних пацієнтів, забезпечити відстань не менше одного метра між ліжками та наявність щонайменше одного унітаза на 20 ліжок, відобразивши зазначені заходи в планах дій з ППК.

Підсумовуючи, у 2025 році система ППК демонструє відчутний прогрес у плануванні, регламентації та навчанні персоналу, однак інтегральне виконання всіх мінімальних вимог залишається нижчим за 50% як у амбулаторній, так і у стаціонарній ланках. Найбільш критичними залишаються інфраструктурні аспекти передачі та дефіцит рутинного нагляду за *Clostridioides difficile* у стаціонарах. Для досягнення стійкого ефекту необхідні скоординовані дії МОЗ/НСЗУ/ЦГЗ, адресне фінансування інфраструктури, стандартизація збору та валідації даних, а також регулярний аудит і прозора зворотна комунікація із закладами.